

Tuberculose · diagnóstico, TRM e PQT

TB pulmonar: tosse "e 2–3 semanas pede investigação. TRM-TB agiliza diagnóstico e resistência à rifampicina; tratamento básico é RIPE supervisionado.

Esquema básico (conceito)

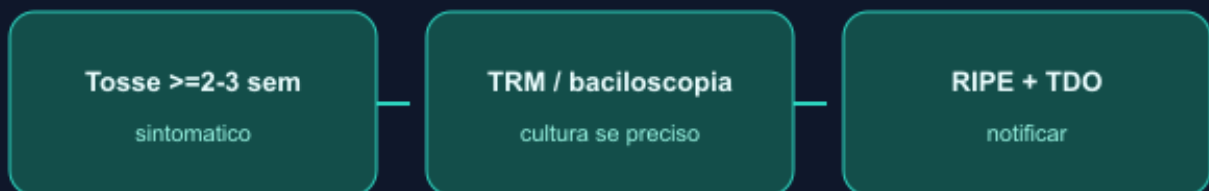
Lembre - Esquema básico (conceito)

2 meses RHZE + 4 meses RH no adulto sensível (doses/ajuste pediátrico e situações especiais conforme Manual MS). TDO melhora adesão.

Busca ativa na APS + confirmação laboratorial + início precoce do esquema.

Sintomático respiratório

Rastrear -> TRM/escarro -> tratar



Pontos high-yield

- Notificação compulsória; examinar contatos; TLT (IGRA/PPD) em elegíveis
- HIV: testar todo caso de TB; ajustar timing de TARV
- Extrapulmimar: pensar em miliare, meníngea, pleural — cultura/histologia
- Falha/resistência: TRM com rifampicina resistente !' referência

Ferramentas diagnósticas

Teste | Papel

TRM-TB | Diagnóstico rápido ± rif-R

Baciloscopia | Acompanhamento / disponibilidade

Cultura + TS | Padrão e resistência

Rx tórax | Apoio; não confirma sozinho

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não suspenda RHZE por 'hepatite leve' sem critérios — mas hepatotoxicidade grave exige conduta específica. Contato de TB bacilífera: avaliar TLT; BCG não trata infecção latente.

Para a prova — escalas e macetes

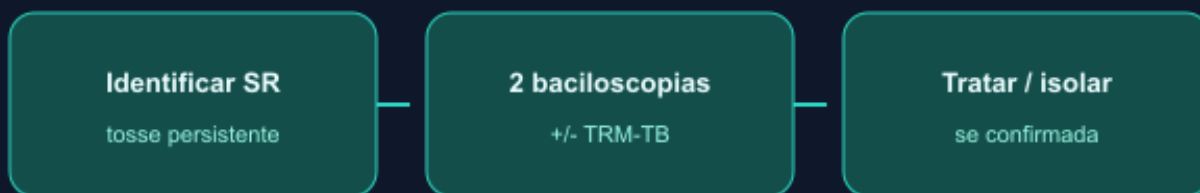
Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Sintomático respiratório (SR): tosse por tempo-limiar (ideia "e 2–3 semanas) !' coletar escarro; clássico pedir 2 baciloskopias (e TRM conforme rede).

Fluxo APS: identificar SR !' coletar amostras !' TRM/baciloscopia !' tratar/isolar se TB.

Sintomático respiratório

Tosse -> 2 amostras -> conduta



Critérios e coleta clássicos do sintomático respiratório.

Critérios SR e coleta

O essencial de prova

- 1 SR: tosse por $\geq$ 2-3 semanas (ideia de prova/MS)
- 2 Coletar escarro: ideal 2 amostras
- 3 Preferir TRM-TB onde disponível
- 4 Bacilo + = alta transmissibilidade: isolar/tratar

SR e diagnóstico baciloscópico

Item | Ideia clássica de prova

Sintomático respiratório | Tosse por $\geq$ 2–3 semanas (conferir protocolo vigente no enunciado)

1ª amostra | No momento da identificação (escarro espontâneo)

2ª amostra | Preferencialmente no dia seguinte (jejum/manhã)

TRM-TB | Priorizar na rede — mais sensível e informa rifampicina

Se baciloscopia + | Iniciar fluxo de TB pulmonar bacilífera + isolamento

Por que 2 baciloscopias?

- Aumenta sensibilidade frente a uma única amostra
- Ajuda a estimar carga bacilar e transmissibilidade
- Negativas seriadas não excluem TB — siga investigação se alta suspeita
- Em crianças a coleta pode ser gástrica/induzida — enunciado guia

Armadilha

Atenção - Armadilha

Tratar só 'pneumonia ambulatorial' sem pensar em SR/TB atrasa diagnóstico e mantém transmissão.

Em tosse persistente, peça escarro.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1